予想問題　第3回

総合問題

医学科

問題

愛媛大学 前期日程 対策

医学部 医学科（個別学力検査「総合問題」の英文読解・論述）

試験時間 120 分 ／ 200 点満点（時間・配点は本書の想定）

はじめに読むこと

問題は問題1・問題2の2題です。解答はすべて解答用紙の指定のところに書きなさい。

字数制限のある問題は、句読点も1字に数えます。問題冊子の余白は下書きに使ってかまいません。

愛媛大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

出題の形式・分量は、大学が公開している過去の問題を研究して設定しました。英文・設問・図表・解答はすべてマナトビ編集部の書き下ろしです。

問題1 医療・科学の英文 （配点 100 点）

以下は、地域の健康づくりについて、ある国際的な保健機関が発行した報告書の一部（架空）である。これを読み、問1～問6に答えよ。*印の語には本文の後に注を付した。字数を指定した問いでは、句読点やかっこも1字として数える。

Loneliness as a Health Risk

For a long time, loneliness was regarded as a private feeling rather than a medical concern. A person who felt isolated might be pitied, but few doctors would have written it in a patient's notes. ①Over the past two decades, however, a large body of research has linked long-term social isolation to higher rates of heart disease, stroke*, depression, and dementia*. Some researchers have gone so far as to compare its effect on life expectancy with that of smoking.

It is important to separate two ideas that are often confused. Social isolation refers to an objective lack of contact with others: living alone, rarely meeting friends, having no one to call in an emergency. Loneliness, by contrast, is a subjective feeling — the painful sense that one's relationships are not as close or as many as one would like. ②A person can be surrounded by family and still feel lonely, while another who lives alone may feel perfectly content. Both conditions appear to affect health, but they may require different responses.

Why should loneliness harm the body? One explanation is that humans evolved in small groups, where being cut off from others meant real danger. ③As a result, the brain may treat social disconnection as a threat, keeping the body in a state of constant alert that, over many years, wears down the heart and immune system. Lonely people may also sleep less well, exercise less, and be less likely to seek medical help when they need it.

Several countries have begun to respond. In some regions, doctors can now practice "social prescribing": instead of, or in addition to, medicine, they refer patients to community activities such as walking groups, gardening clubs, or volunteer work. Early evaluations suggest that participants report better well-being and visit their doctors less often, although the long-term effects are still being studied. ④The idea is not that a gardening club can cure disease, but that a reason to leave the house and a person who notices one's absence can make a real difference.

Tackling loneliness, however, cannot be left to the health system alone. Town planning, public transport, and the design of housing all shape how easily people can meet. ⑤A bench placed in the right spot, a bus route that reaches an isolated neighborhood, or a library that stays open in the evening may do as much for public health as a new clinic.

---

*stroke 脳卒中 *dementia 認知症

問1 下線部①について、長期の社会的孤立と関連があるとされる病気を、本文中から英語で3つ抜き出せ。

問2 下線部②の内容を、social isolation と loneliness の違いが明らかになるように、60字以内の日本語で説明せよ。

問3 下線部③を、本文の趣旨がわかるように、100字以内の日本語に訳せ。

問4 下線部④の考え方を、social prescribing の内容を明らかにしながら日本語で説明せよ。

問5 下線部⑤に込められた筆者の主張を、80字以内の日本語でまとめよ。

問6 高齢化と人口減少が進む地域で、医師として住民の孤立や孤独にどのように関わることができるか。本文の内容をふまえ、具体的な取り組みを挙げながら、あなたの考えを240字以内の日本語で述べよ。

問題2 臨床の状況と専門家の見解 （配点 100 点）

あなたは小児科の外来に勤める医師で、文章1のような場面に出会った。これについて、ある小児科医が文章2の見解を述べている（いずれも架空）。二つの文章を読み、問1～問4に答えよ。字数を指定した問いでは、句読点やかっこも1字として数える。

文章**1**

Kenta, aged 14, has had type 1 diabetes* since he was eight. Until last year he managed his insulin* injections well, but recently his blood sugar levels have been poorly controlled, and he was briefly hospitalized last month. Today he comes to the clinic with his mother. When you ask how things are going, his mother answers before he can speak. “He forgets his injections. He eats junk food with his friends. I check his phone to see where he is, but he lies to me.” Kenta stares at the floor. When his mother steps out to make a phone call, he says quietly, “①I just want one day where I don’t have to think about being sick. Nobody at school has to count everything they eat.”

文章**2**

Adolescence is a difficult time to have a chronic illness. Teenagers are trying to become independent and to fit in with their friends, while a disease like diabetes demands constant attention and makes them feel different. ②Poor control at this age is often less a sign of carelessness than a sign of a young person struggling to balance two needs that seem to be in conflict.

Parents, understandably frightened, may respond by watching more closely. But increased control often leads to more resistance, and the clinic visit can turn into a place where the young person is judged. ③The doctor’s task is to make room for the teenager’s own voice, for example by spending part of each visit with the patient alone and by setting goals together rather than handing down rules.

This does not mean taking the teenager’s side against the parents. The aim is to help the family move gradually from a model in which the parent is responsible to one in which the young person is. ④Responsibility is not something that can be given all at once; it grows through small successes that the teenager recognizes as his own.

---

*diabetes 糖尿病 *insulin インスリン（血糖値を下げるホルモン）

問1 次の文は、文章2の内容を医学生がまとめたものである。空所 (a)～(e) に入れるのに最もふさわしい語を、下の語群からそれぞれ1つずつ選び、記号で答えよ。同じ語を二度用いてはならない。

Teenagers with a chronic illness want to be (a) and to fit in, so poor control may reflect a (b) rather than carelessness. Closer watching by parents can cause more (c). Doctors should listen to the teenager and set goals (d). Responsibility should be passed on (e), through small successes.

(A) independent (B) struggle
(C) resistance (D) together
(E) gradually (F) immediately
(G) punishment (H) separately

問2 下線部①の健太さんの発言から読み取れる気持ちを、文章2の下線部②の考え方と関連づけて、100字以内の日本語で述べよ。

問3 下線部③の the teenager’s own voice を大切にするために、筆者はどのような方法を挙げているか。また、下線部④の考え方を、健太さんの場合に当てはめて具体的に説明せよ。

問4 文章1の場面で、あなたが医師であれば、健太さんと母親にそれぞれどのように関わるか。文章2の見解に対するあなたの評価も含めて、300字以内の日本語で述べよ。

解答用紙　問題1

愛媛大学 総合問題（英文） 予想問題 第3回　　受験番号（　　）　氏名（　　）

問1

問2

（60字以内）

問3

（100字以内）

問4

問5

（80字以内）

問6

（240字以内）

小計（　　）点

解答用紙　問題2

愛媛大学 総合問題（英文） 予想問題 第3回　　受験番号（　　）　氏名（　　）

問1（a）

問1（b）

問1（c）

問1（d）

問1（e）

問2

（100字以内）

問3

問4

（300字以内）

小計（　　）点

奥　付

書名	国公立2次 英語 予想問題 愛媛大学 前期日程 対策 第3回（問題）
想定	愛媛大学　医学部 医学科（個別学力検査「総合問題」の英文読解・論述）
構成	問題1 医療・科学の英文（抜き出し・字数制限つき説明・和訳・意見）100点／問題2 臨床の状況文と意見文（考察・論述）100点
編集・作問	マナトビ編集部（2026年11月）

愛媛大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本書の英文・設問・図表・解答・解説はすべて書き下ろしです。実在の試験問題、解答速報、講評などの文章は使っていません。出題の形式は公開されている過去の問題を参考に設定したもので、実際の出題を保証するものではありません。登場する人物・団体・調査はすべて架空です。

予想問題　第3回

総合問題

医学科

解答・解説

愛媛大学 前期日程 対策

医学部 医学科（個別学力検査「総合問題」の英文読解・論述）

試験時間 120 分　／　200 点満点（時間・配点は本書の想定）

はじめに読むこと

解答例は一例です。記述問題は、同じ内容が正しく書けていれば別の表現でも得点できます。
各設問の「解説」で、本文のどこを根拠にするかを示しています。全訳・重要語句も確認しましょう。
論述問題は「出題の意図」と「採点の観点」を示しています。

愛媛大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

出題の形式・分量は、大学が公開している過去の問題を研究して設定しました。英文・設問・図表・解答はすべてマナトビ編集部の書き下ろしです。

問題1　医療・科学の英文　解答・解説　（配点 100 点）

設問	解答（例）	配点
問1	heart disease / stroke / depression / dementia から3つ	9
問2	孤立は他者との接触が客観的に少ない状態、孤独は関係に満足できない主観的な感情なので、家族に囲まれても孤独な人も、一人で満足な人もいる。	12
問3	その結果、脳は社会的なつながりが断たれることを脅威として扱い、体を絶えず警戒した状態に保つのかもしれない。その状態が長年続くと、心臓や免疫系がすり減っていく。	16
問4	social prescribing とは、医師が薬の代わりに、あるいは薬に加えて、散歩の会や園芸クラブ、ボランティア活動などの地域の活動に患者をつなぐこと。園芸クラブが病気を治すわけではないが、家を出る理由と、自分がいないことに気づいてくれる人がいることが、健康に実際の違いをもたらすという考え方。	15
問5	孤独への対策は医療だけに任せられず、人が出会いやすい街づくりが重要で、適所のベンチや孤立地区へのバス路線などが新しい診療所と同じほど公衆衛生に役立つということ。	14
問6	解答例は解説欄参照	34

▌解説

問1　下線部①の higher rates of heart disease, stroke, depression, and dementia から3つ。各3点。

問2　客観的な状態（isolation）と主観的な感情（loneliness）の区別をはっきり書く。

問3　As a result は「人類は小集団で進化し、孤立は危険を意味した」を受ける。treat A as B「AをBとして扱う」、keeping … は分詞構文（結果）、that, over many years, wears down … は state of constant alert を先行詞とする関係詞節。

問4　social prescribing の説明 6点、not that A but that B の対比（治すのではなく、外出の理由と気づいてくれる人）9点。

問5　直前の「健康システムだけに任せられない」「街の計画・交通・住宅が出会いやすさを左右する」と結びつけて80字以内で。

問6　【出題の意図】孤独・孤立を健康の危険因子として理解し、医師が医療の枠を越えて地域とどう連携できるかを具体的に考えさせる。
【採点の観点】①地域の状況（高齢化・人口減少・移動の困難）をふまえている ②本文の論点（孤立と孤独の区別、社会的処方、街づくり）を活用している ③医師としての具体的な関わり（気づく・つなぐ・働きかける）が示されている ④多職種・行政との連携への言及 ⑤字数・論理・表現。

▌全訳

【健康を脅かすものとしての孤独】長い間、孤独は医学的な問題というより個人的な感情とみなされていた。孤立していると感じる人は同情されることはあっても、それを患者の記録に書く医師はほとんどいなかっただろう。(①) しかしこの20年で、多くの研究が長期の社会的孤立を、心臓病、脳卒中、うつ病、認知症の発生率の高さと結びつけてきた。その平均寿命への影響を喫煙の影響と比べる研究者さえいる。

しばしば混同される二つの考えを区別することが大切だ。社会的孤立とは、他者との接触が客観的に欠けていることを指す。一人暮らしで、友人にめったに会わず、緊急時に電話する相手もいない。それに対して孤独は主観的な感情であり、自分の人間関係が望むほど親密でも多くもないというつらい感覚である。(②) 家族に囲まれていて

も孤独を感じる人もいれば、一人暮らしでもまったく満足している人もいる。どちらの状態も健康に影響するようだが、必要な対応は異なるかもしれない。

なぜ孤独が体を害するのだろうか。一つの説明は、人類は小さな集団の中で進化し、他者から切り離されることは現実の危険を意味したというものだ。(③) その結果、脳は社会的なつながりの断絶を脅威として扱い、体を絶えず警戒した状態に保つのかもしれない。それが長年にわたって心臓と免疫系をすり減らす。孤独な人は眠りが浅く、運動が少なく、必要なときに医療の助けを求めにくい傾向もある。

いくつかの国が対応を始めている。一部の地域では、医師は今や「社会的処方」を行うことができる。薬の代わりに、あるいは薬に加えて、患者を散歩の会や園芸クラブ、ボランティア活動などの地域の活動に紹介するのだ。初期の評価では、参加者の幸福感が高まり、医師の受診回数が減ったことが示唆されているが、長期的な効果はまだ研究中である。(④) 園芸クラブが病気を治せるということではなく、家を出る理由と、自分がいないことに気づいてくれる人が、実際の違いを生みうるという考えなのだ。

しかし、孤独への取り組みを医療制度だけに任せることはできない。都市計画、公共交通、住宅の設計はすべて、人々がどれだけ簡単に出会えるかを左右する。(⑤) ちょうどよい場所に置かれたベンチ、孤立した地区に届くバス路線、夜も開いている図書館は、新しい診療所と同じくらい公衆衛生に役立つかもしれない。

重要語句

regard A as B　AをBとみなす
isolated　孤立した
pity　同情する
a body of research　一連の研究
life expectancy　平均寿命
objective　客観的な
subjective　主観的な
content　満足した
disconnection　断絶
alert　警戒
wear down　すり減らす
immune system　免疫系
refer A to B　AをBに紹介する
evaluation　評価
well-being　幸福、健康

問題2　臨床の状況と専門家の見解　解答・解説　（配点 100 点）

設問	解答（例）	配点
問1	(a)A (b)B (c)C (d)D (e)E	20
問2	病気を一日も忘れられない負担に疲れ、友人と同じように普通に過ごしたいという気持ち。血糖管理の乱れは不注意ではなく、自立や仲間との一体感と病気の管理との間で葛藤している表れだと考えられる。	18
問3	方法＋具体例は解答例参照	20
問4	解答例は解説欄参照	42

▌解説

問1　(a) trying to become independent。(b) a young person struggling to balance two needs。(c) increased control often leads to more resistance。(d) setting goals together。(e) move gradually / grows through small successes。各4点。

問2　健太さんの気持ち（病気を意識し続ける疲れ・友人と同じでいたい）と、②（不注意より葛藤の表れ）との結びつきを100字以内で。

問3　方法2つ 各4点、④の具体化（小さな目標・本人の成功として認める・段階的に）12点。

問4　【出題の意図】思春期の慢性疾患患者の自立支援と、家族との関係調整について、医師としての関わり方を具体的に考えさせる。
【採点の観点】①本人の気持ちへの共感と対話の工夫 ②母親への配慮と説明 ③段階的な自己管理の支援 ④安全面の配慮 ⑤文章2への評価が論理的 ⑥字数・構成・表現。
【加点要素】ピアサポート、学校・多職種との連携、技術的支援（持続血糖測定器など）への言及。

▌全訳

【文章1】14歳の健太さんは、8歳のときから1型糖尿病を患っている。昨年まではインスリン注射をきちんと管理していたが、最近は血糖値のコントロールが悪く、先月は短期間入院した。今日、彼は母親と一緒に外来に来ている。調子を尋ねると、彼が話す前に母親が答える。「注射を忘れるんです。友だちとジャンクフードを食べるし。居場所を知るために携帯を見ていますけど、うそをつくんです」。健太さんは床を見つめている。母親が電話をかけに出て行くと、彼は小声で言う。「(①) 病気のことを考えなくていい日が、一日でいいから欲しいんです。学校で食べる物を全部数えなきゃいけない人なんていない」。

【文章2】思春期は慢性の病気を抱えるには難しい時期だ。十代は自立しようとし、友人になじもうとしているが、糖尿病のような病気は絶えず注意を求め、自分は人と違うと感じさせる。(②) この年代のコントロールの悪さは、不注意の表れというより、対立するように見える二つの欲求のバランスをとろうと苦しんでいる若者の表れであることが多い。

親は、無理もないことだが怖くなって、より厳しく見張ることで応じるかもしれない。しかし管理を強めると反発が強まることが多く、診察が若者の裁かれる場になってしまうこともある。(③) 医師の仕事は、十代の本人の声のための場所をつくることだ。たとえば、毎回の診察の一部を患者と二人だけで過ごしたり、規則を言い渡すのではなく一緒に目標を立てたりすることによって。

これは、親に対抗して十代の側につくということではない。目的は、親が責任を持つ形から若者自身が責任を持つ形へと、家族が少しずつ移っていくのを助けることである。(④) 責任は一度にすべて与えられるものではない。それは、十代の本人が自分自身のものだと認められる小さな成功を通して育っていくのである。

▌重要語句

diabetes　糖尿病
insulin　インスリン
injection　注射
blood sugar　血糖

hospitalize　入院させる
chronic　慢性の
fit in　なじむ
carelessness　不注意
understandably　無理もないことだが
resistance　反発
hand down　言い渡す
take one’s side　～の味方をする
gradually　徐々に
all at once　一度に

奥　付

書名	国公立2次 英語 予想問題 愛媛大学 前期日程 対策 第3回（解答・解説）
想定	愛媛大学　医学部 医学科（個別学力検査「総合問題」の英文読解・論述）
構成	問題1 医療・科学の英文（抜き出し・字数制限つき説明・和訳・意見）100点／問題2 臨床の状況文と意見文（考察・論述）100点
編集・作問	マナトビ編集部（2026年11月）

愛媛大学の過去問・公式問題ではありません。予想問題であり、大学とは関係がありません。

本書の英文・設問・図表・解答・解説はすべて書き下ろしです。実在の試験問題、解答速報、講評などの文章は使っていません。出題の形式は公開されている過去の問題を参考に設定したもので、実際の出題を保証するものではありません。登場する人物・団体・調査はすべて架空です。